

HIPO

Lidia Anastasia Alvarado Machón, Ángeles Lafont Alcalde , Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El hipo es un ruido característico producido por la brusca expulsión del aire del pulmón durante la contracción involuntaria, brusca y espasmódica del diafragma, que provoca la sacudida de los músculos inspiratorios del tórax y del abdomen, seguida del cierre brusco de la glotis. Es un acto reflejo en el que intervienen las fibras aferentes de los nervios frénico y vago, las conexiones con el tronco del encéfalo en el que se encuentra el centro del hipo, y las vías eferentes, a través de los nervios cervicales, torácicos, frénico y vago.

Clasificación del Hipo en función de la duración

Según la duración del hipo se clasifica en:

- **Hipo agudo:** episodios de segundos o minutos de duración.
- **Hipo persistente:** con una duración mayor de 48 horas.
- **Hipo recurrente:** episodios más duraderos que el transitorio y repetidos con frecuencia.
- **Hipo intratable:** Se mantiene de forma continuada durante más de un mes.

Hipo transitorio

La mayoría de las crisis de hipo son autolimitadas y a pesar de ser algo muy frecuente, no tienen repercusión clínica y a veces son motivo de consulta.

En la mayoría de las ocasiones se desconoce su etiología.

PRINCIPALES CAUSAS DE HIPO TRANSITORIO
Distensión gástrica, aerofagia, comidas copiosas, irritantes
Ingesta de bebidas gasificadas o alcohol
Cambios bruscos de temperatura: ingesta fría o caliente
Estados emocionales: ansiedad, estrés

Hipo persistente

El hipo persistente puede ser una manifestación de patología severa subyacente o un signo de alarma de alguna complicación, como por ejemplo una dehiscencia de sutura en un postoperatorio, por lo que requerirá de un estudio más amplio.

El hipo es también un síntoma relativamente frecuente en el paciente terminal; en estos pacientes el hipo puede ser consecuencia de la distensión gástrica por vaciamiento retardado, por menor motilidad, o por compresión extrínseca (hepatomegalia, ascitis, tumor abdominal).

Las causas de hipo persistente es muy amplia y entre ellas, las causa más frecuente son las enfermedades gastroesofágicas.

PRINCIPALES CAUSAS DE HIPO PERSISTENTE

- **Irritación del nervio frénico o vago**

- Esofagitis por ERGE o candidiásica, acalasia, divertículos esofágicos, cáncer de esófago.
- Hernia de hiato, distensión gástrica, tumores gástricos, gastritis crónica, úlcera gástrica.
- Obstrucción de intestino delgado, íleo.
- Enfermedad pancreática o biliar: pancreatitis, colangitis.
- Ascitis, embarazo, laparotomía.
- Laringitis, faringitis.
- Bocio.
- Lesiones mediastínicas: tumores, mediastinitis, aneurisma de aorta.
- Derrame pleural, neumonía, TBC, cáncer de pulmón.
- Infarto de miocardio, derrame pericárdico.
- Irritación diafragmática: tumor, absceso subfrénico o hepático, hernia diafragmática.

- **Lesiones del SNC**

- Procesos inflamatorios/infecciosos: encefalitis, meningitis, sífilis, VIH.
- Lesiones medulares: infarto,iringomielia, tumores, procesos desmielinizantes.
- Alteraciones circulatorias: hipertensión intracraneal, hemorragia intracraneal.
- Traumatismos craneoencefálicos.
- Alcoholismo.

- **Causas metabólicas:** uremia, cetoacidosis diabética, hiponatremia, hipocalcemia, hiperuricemia, enfermedad de Addison.

- **Fármacos:** corticoides, alfametildopa, benzodiacepinas, neurolépticos, barbitúricos de acción corta, imipenem, azitromicina.

- **Quirúrgicas:** anestesia general, post cirugía abdominal.

- **Psicógeno:** histeria, ansiedad, simulación.

DIAGNÓSTICOHistoria clínica

- Se basa en una anamnesis, examen físico detallado y exhaustivo con pruebas complementarias dirigidas según la sospecha clínica.
Antecedentes personales: Incluir episodios anteriores, duración, hábitos tóxicos, fármacos y enfermedades metabólicas conocidas.
- Enfermedad actual: sintomatología gastrointestinal (pirosis, regurgitación, disfagia, vómitos, dolor abdominal), cardiorrespiratoria (tos, fiebre, disnea, dolor torácico), neurológica (cefalea, diplopía, vértigo, náuseas, disfagia, alteración de la sensibilidad), presencia del hipo durante el sueño (orienta hacia enfermedad orgánica), relación con algún desencadenante.

Exploración física

Constantes vitales, exploración cardiorrespiratoria (en busca de signos de enfermedad pleural o pericárdica), exploración abdominal (signos de estasis gástrica, obstrucción intestinal, hepatomegalia), exploración neurológica, exploración otorrinolaringológica (descartar cuerpo extraño en conducto auditivo externo).

Pruebas complementarias

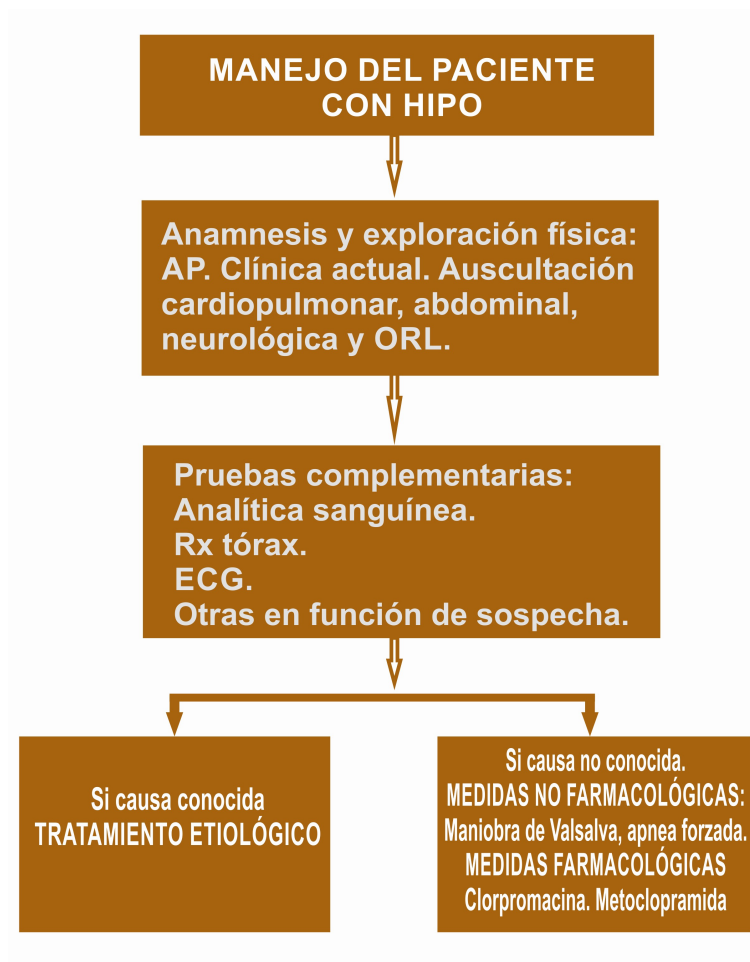
- Hemograma con formula leucocitaria.
- Bioquímica básica con pruebas de función hepática.
- Radiografía de tórax.
- ECG.

Otras pruebas en función de sospecha clínica: ecografía, colonoscopia, gastroscopia, TC craneal/ torácico/ abdominal...

TRATAMIENTO

Siempre identificar la causa subyacente y hacer un tratamiento etiológico.

- **Maniobras físicas:** Comenzar con una o varias de estas maniobras de Valsalva: presionar sobre ambos conductos auditivos externos, estímulo faríngeo (tracción de la lengua, provocar estornudos, beber pequeños sorbos de agua fría, estimulación con SNG), respirar dentro de una bolsa de papel...
- **Medidas farmacológicas:** Si las maniobras físicas no han sido efectivas, tomaremos medidas farmacológicas:
 - **Supresión central del reflejo del vómito:**
 - Clorpromazina (Largactil) 25 mg im y continuar con 5mg cada 6-8h vo.
 - Valproato sódico 500-1000 mg casa 24h vo.
 - **Distensión gástrica:**
 - Metoclopramida 10-20 mg/6-8 h vo.
 - Domperidona (motilium) 10-20 mg/6-8 h vo.
 - **Otros:**
 - Baclofeno 5-15 mg/8h vo.
 - Haloperidol 2-12 mg im.
 - Omeprazol 20mg/24h vo.
 - Butilbromuro de ioscina 10-20 mg/8h vo.
 - Amitriptilina 2-12 mg im.
 - Gabapentina 400mg/8h vo.
 - Difenilhidantoína 200 mg iv y continuar con 100 mg/6h vo.
 - Nifedipino 5-10 mg/8h vo.
 - Carbamazepina 200-400 mg/8h vo.
 - Dexametasona: si la causa del hipo es un tumor cerebral, tratamiento específico del tumor cerebral y sintomático con dexametasona.
- **Otros tratamientos:**
 - Interrupción de la transmisión del nervio frénico.
 - Estimulación eléctrica transcutánea del nervio frénico cervical.
 - Bloqueo del nervio frénico izquierdo



BIBLIOGRAFÍA

- García Callejoa FJ, Redondo Martínez J, Pérez Carbonella T, Monzó Gandía R, Martínez Beneyto MP, Rincón Piedrahita I. Hipo. Actitud en otorrinolaringología en pacientes que consultan. Aproximación diagnóstica y terapéutica. Acta Otorrinolaringologica. Esp. 2017; 68(2): 98-105.
- Goñi Murillo MC. Actitud ante un paciente con hipo en atención primaria. Semergen. 2006; 32:233-6.